

1. Introducción y relevancia clínica

Las **neuropatías periféricas** son trastornos que afectan uno o más **nervios periféricos**, produciendo alteraciones en la función sensitiva, motora y autonómica. Constituyen una de las causas más frecuentes de consulta neurológica y un motivo común de discapacidad crónica, especialmente en pacientes diabéticos.

Se estima que aproximadamente **8% de la población mayor de 55 años** presenta algún grado de neuropatía periférica, y que más del **50% de los diabéticos** desarrollará neuropatía durante su evolución.

En Chile, su relevancia es alta por la prevalencia de **diabetes mellitus tipo 2, alcoholismo crónico, deficiencias nutricionales y enfermedades infecciosas o autoinmunes**.

El reconocimiento clínico temprano es crucial, pues **algunas neuropatías son reversibles si se tratan oportunamente**, mientras que otras son progresivas y requieren abordaje multidisciplinario.

En el **EUNACOM**, las preguntas sobre este tema se centran en el **patrón de distribución del déficit, tipos de fibras afectadas y principales etiologías reversibles** (por ejemplo, déficit de B12, diabetes o fármacos neurotóxicos).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **nervio periférico** está compuesto por axones mielinizados y amielínicos, rodeados por células de Schwann.

Las neuropatías pueden afectar principalmente el **axón (axonopatías)** o la **mielina (desmielinizantes)**, y su fisiopatología dependerá del mecanismo predominante.

2.1. Clasificación fisiopatológica

- **Neuropatías axonales:** daño directo del axón, con degeneración distal ("degeneración walleriana"). Causas: diabetes, tóxicos, deficiencias vitamínicas.
- **Neuropatías desmielinizantes:** lesión de la vaina de mielina, con conducción lenta y bloqueos. Ejemplo: síndrome de Guillain-Barré, neuropatías hereditarias.

2.2. Clasificación según extensión

- **Mononeuropatía:** compromiso de un solo nervio (ej.: nervio radial o mediano).
- **Mononeuropatía múltiple:** varios nervios afectados en diferentes territorios.
- **Polineuropatía:** afectación difusa y simétrica, generalmente distal (“en guante y calcetín”).

2.3. Clasificación funcional

- **Sensitivas:** predominan parestesias, disestesias, hipoestesia o dolor.
 - **Motoras:** debilidad, atrofia y arreflexia.
 - **Autonómicas:** hipotensión ortostática, disfunción eréctil, sudoración anormal, trastornos digestivos.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones clínicas generales

El cuadro clínico depende de la extensión, tipo de fibra comprometida y etiología, pero típicamente presenta:

- **Síntomas sensitivos distales y simétricos:** hormigueo, ardor o pérdida de sensibilidad en pies y manos (“patrón en guante y calcetín”).
- **Déficit motor:** debilidad progresiva distal, dificultad para caminar o manipular objetos.
- **Alteraciones reflejas:** hiporreflexia o arreflexia.
- **Síntomas autonómicos:** taquicardia fija, hipotensión ortostática, gastroparesia, impotencia.

El **inicio y progresión** orientan al diagnóstico:

- Agudo → tóxico, infeccioso o inflamatorio (Guillain-Barré).
- Subagudo → déficit vitamínico o inmunológico.
- Crónico → diabetes, alcoholismo, hereditarias.

3.2. Formas clínicas principales

A. Polineuropatía distal simétrica (forma más común)

- Etiología: diabetes mellitus, alcoholismo, insuficiencia renal crónica, tóxicos, deficiencia de B12.
- Predomina compromiso sensitivo distal (pies → manos).
- Dolor neuropático frecuente (ardor, calambres, “descarga eléctrica”).
- Examen: hipoestesia distal, arreflexia aquiliana, debilidad leve.

B. Mononeuropatías

- **Nervio mediano:** síndrome del túnel carpiano (parestias en primer al tercer dedo, empeoran de noche).
- **Nervio cubital:** pérdida de fuerza en flexión de dedos 4°–5° y hipoestesia en borde cubital.
- **Nervio radial:** caída de muñeca.
- **Nervio peroneo común:** caída del pie, hipoestesia dorso del pie.

C. Mononeuropatías múltiples

- Lesiones asimétricas y no contiguas de varios nervios.
- Causas: vasculitis, diabetes, lepra, amiloidosis.

D. Neuropatía autonómica

- Afecta fibras simpáticas y parasimpáticas.
- Manifestaciones: hipotensión ortostática, gastroparesia, constipación o diarrea, impotencia, disfunción vesical.
- Muy común en diabetes avanzada.

E. Neuropatía inflamatoria aguda (Síndrome de Guillain-Barré)

- Polirradiculoneuropatía desmielinizante aguda, postinfecciosa (Campylobacter jejuni, CMV, EBV).
 - Parálisis ascendente flácida, arreflexia y compromiso respiratorio.
 - Urgencia neurológica (manejo hospitalario).
-

3.3. Diagnóstico diferencial

- **Miopatías:** debilidad proximal, sin alteraciones sensitivas.
- **Radiculopatías:** dolor y déficit en distribución dermatomérica.
- **Trastornos de unión neuromuscular (Miastenia Gravis):** fatigabilidad, sin trastornos sensitivos.
- **Lesión medular:** patrón bilateral con nivel sensitivo.

Comentario EUNACOM:

El patrón “distal, simétrico y progresivo” orienta a **polineuropatía diabética**, mientras que un déficit focal y doloroso sugiere **mononeuropatía por atrapamiento**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico se basa en **clínica + estudios electrofisiológicos** y en la **búsqueda de la causa subyacente**.

4.1. Evaluación básica

- **Historia clínica detallada:** fármacos, alcohol, síntomas autonómicos, antecedentes familiares.
- **Examen neurológico:** distribución sensitivo-motora y reflejos.

4.2. Exámenes de laboratorio iniciales (MINSAL 2023)

- Glicemia y HbA1c (descartar diabetes).
- Uremia, creatinina.

- TSH y T4 libre (hipotiroidismo).
- Niveles de vitamina B12 y ácido fólico.
- VDRL, VIH, pruebas hepáticas.
- Electrolitos (Ca, Mg, K).

4.3. Estudios especializados

- **Electromiografía (EMG) y velocidad de conducción nerviosa:**

Diferencia entre neuropatías axonales (amplitud disminuida) y desmielinizantes (velocidad disminuida).

- **Biopsia de nervio sural:** casos atípicos o sospecha de vasculitis/amiloidosis.
- **Punción lumbar:** útil en sospecha de Guillain-Barré (disociación albúmino-citológica).

5. Tratamiento (según MINSAL y guías internacionales 2024)

El tratamiento debe enfocarse en **controlar la causa, prevenir progresión y aliviar el dolor neuropático**.

5.1. Manejo etiológico

- **Diabética:** control glicémico estricto (HbA1c <7%).
 - **Carencial (B12):** cianocobalamina IM 1000 µg/semana por 1 mes, luego mensual.
 - **Alcohólica:** abstinencia + complejo B.
 - **Uremia:** considerar diálisis o trasplante renal.
 - **Tóxica:** suspender agente causal (quimioterapia, metronidazol, amiodarona).
 - **Infecciosa:** tratar agente (lepra, VIH, Lyme).
-

5.2. Tratamiento del dolor neuropático

El dolor neuropático requiere manejo multimodal y sostenido.

Primera línea:

- **Gabapentina:** 300–1200 mg cada 8 h.
- **Pregabalina:** 75–300 mg c/12 h.
- **Duloxetina:** 30–60 mg/día (inhibidor dual de recaptación de serotonina/noradrenalina).
- **Amitriptilina:** 10–50 mg/noche (en casos seleccionados).

Segunda línea:

- Tramadol o combinación de antiepilépticos.
- Capsaicina tópica o lidocaína parches.

Comentario EUNACOM:

En pacientes diabéticos con dolor neuropático, la **duloxetina** o **pregabalina** son las opciones más recomendadas según MINSAL 2023.

5.3. Rehabilitación y medidas generales

- Ejercicio físico y fisioterapia.
- Cuidado podológico (diabéticos).
- Educación en prevención de lesiones por insensibilidad.
- Calzado adecuado.

En neuropatías autonómicas:

- Ingerir líquidos abundantes y medias elásticas (hipotensión ortostática).
 - Ajuste de insulina y horarios de alimentación (gastroparesia).
-

6. Complicaciones

- **Úlceras plantares y amputaciones** (por insensibilidad y trauma repetido).
- **Infecciones de pies.**
- **Caídas y fracturas.**
- **Dolor crónico e insomnio.**
- **Depresión y pérdida de funcionalidad.**

En neuropatías autonómicas:

- **Arritmias, hipotensión postural severa, retención urinaria.**
-

7. Pronóstico

El pronóstico depende de la causa.

- **Diabética:** curso crónico, controlable pero no reversible.
- **Carenciales o tóxicas:** recuperación parcial o total si se trata precozmente.
- **Inflamatorias (Guillain-Barré):** recuperación completa en 80% con manejo oportuno.
- **Hereditarias:** progresión lenta, sin tratamiento curativo.

El tratamiento sintomático y la rehabilitación mejoran la calidad de vida y previenen discapacidad.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Patrón “en guante y calcetín” → polineuropatía distal simétrica.
2. Neuropatía más frecuente en Chile: **diabética distal sensitivo-motora.**

3. La **mononeuropatía del mediano** (túnel carpiano) es muy común en EUNACOM.
4. Déficit de **vitamina B12** produce neuropatía sensitivo-motora + anemia megaloblástica.
5. La **EMG** es el examen clave para confirmar el tipo de neuropatía.
6. La **neuropatía aguda ascendente** siempre debe hacer sospechar **Guillain-Barré**.
7. En **dolor neuropático**, las drogas de elección son **gabapentinoides o duloxetina**, no AINES.

Errores comunes:

- No buscar la causa metabólica (diabetes, hipotiroidismo).
- Tratar neuropatía diabética sólo con analgésicos comunes.
- Ignorar síntomas autonómicos.
- Diagnosticar Guillain-Barré sin punción lumbar ni EMG.
- No examinar pies en control de pacientes diabéticos.

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. Las **neuropatías periféricas** son alteraciones del nervio periférico que provocan síntomas sensitivos, motores y autonómicos.
2. Su presentación típica es **distal, simétrica y crónica**, sobre todo en **diabéticos y alcohólicos**.
3. El diagnóstico se confirma con **electromiografía** y la **identificación de la causa**.
4. El tratamiento depende de la etiología y se centra en **control metabólico y alivio del dolor neuropático**.
5. **Gabapentina, pregabalina y duloxetina** son fármacos de primera línea para dolor.
6. En EUNACOM, el patrón clínico y la asociación con diabetes o déficit de B12 son los puntos más evaluados.